

Beslenme Reddi ve İştahsızlık

Beslenme reddi ve iştahsızlığa Pediatrik Beslenme Bozukluğu (PFD) çatısı altında dört alanlı (medikal, beslenme, oral-motor beceri, psikososyal) yaklaşım; oral-motor disfonksiyon, GÖRH/EoE ve disfajinin ayrımı, dozlu tedavi ve multidisipliner izlem. ARFID ve organik hastalık ayrımı odağında.

PFD — Goday 2019 (4 alan)

ARFID — DSM-5

GÖRH / EoE — ESPGHAN/NASPGHAN

Multidisipliner beslenme

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Beslenme reddi, çocuğun sunulan besini almayı reddetmesi veya öğünü tolere edememesi; iştahsızlık ise açlık algısının/yeme isteğinin azalmasıdır. İkisi de bir semptomdur, tanı değildir. Güncel çatı Pediatrik Beslenme Bozukluğu (PFD): yaşa uygun oral alımın bozulması ile birlikte medikal, beslenme (nutrisyonel), oral-motor beceri ve psikososyal alanlardan en az birinde disfonksiyon. İlk görev, davranışsal/işlevsel bir zeminde mi yoksa altta yatan organik bir hastalık (GÖRH, EoE, disfaji/aspirasyon, anatomik/nöromusküler) zemininde mi olduğunu ayırmak ve büyüme riskini derecelendirmektir.

PFD = 4 alan: medikal · beslenme · beceri · psikososyal

Ağrılı yutma → öğrenilmiş red

Öksürük/ıslak ses → aspirasyon/disfaji

Seçicilik + kilo kaybı → ARFID

Toddler'da yavaşlama → fizyolojik olabilir

Öykü

- Başlangıç ve seyir: doğumdan itibaren (konjenital/nöromusküler), prematürite ve YDYBÜ öyküsü, sonda/entübasyon (oral-aversif deneyim); ani başlangıç bir tetikleyici olayı (boğulma, kusma, zorla besleme) düşündürür.
- Alım niteliği ve repertuar: sıvı-katı ilerletme, tekstüre özgü red, seçici yeme, gıda çeşidi (ARFID için <20 gıda tipik), öğün süresi (>30 dk uzamış öğün).
- Beslenmeyle ilişkili bulgular: öksürük-boğulma-ıslak ses, kaviste boyun gerginliği (Sandifer), yutma sonrası irritabilite/ağlama, regürjitasyon-kusma, food impaction.
- Ağrı/organik ipuçları: odinofaji, dispepsi, hematemez, kronik kabızlık, ishal/kanlı gaita (İMPA, çölyak, IBD), atopi (astım/egzama/besin alerjisi → EoE).
- Sistemik: tekrarlayan solunum enfeksiyonu/pnömoni, kardiyak/solunumsal yorgunluk, ilaçlar (metilfenidat, topiramet), kronik hastalık, gelişimsel gerilik.
- Psikososyal/etkileşim: zorla/baskıcı besleme, öğün çatışması, kaygı, aile beslenme davranışı, öğün ortamı ve ebeveyn algısı ("hiç yemiyor").

Muayene

- Antropometri ve büyüme eğrisi: kilo, boy, BKİ persantili ve trend; z-skor düşüşü, büyümede duraklama/kayma nutrisyonel riski ve organik yükü işaretler.
- Beslenme gözlemi (mümkünse doğrudan): emme-yutma-solunum koordinasyonu, salya birikimi, öğün sırasında öksürük/desatürasyon, oral-motor beceri ve tekstür toleransı.

- Orofasial: yarık damak/dudak, yüksek damak, tonsiller hipertrofi, aft/ülser, oral kandidiazis, diş çürüğü/erozyon, oral hipersensitivite.
- Nörolojik: tonus, kraniyal sinirler, öğürme refleksi, bulbar bulgular; genel gelişim ve etkileşim değerlendirmesi.
- Sistemik: dismorfizm/sendromik bulgu, kardiyak üfürüm-takipne, solunum (stridor/hışıltı), batın (distansiyon, fekal kitle), atopi/cilt bulguları.
- Beslenme yetersizliği bulguları: kas kütlesi/deri altı yağ kaybı, ödem, mikrobesein eksikliği (çinko-demir) işaretleri, dehidratasyon.

ARFID (DSM-5, Rome IV ile örtüşür): yeterli enerji/besin alımı sağlanamaması sonucu belirgin kilo kaybı/büyüme geriliği, mikrobesein eksikliği, enteral/oral takviye bağımlılığı veya psikososyal işlevsellikte bozulma; beden imajı bozukluğu ya da açlığı yadsıma YOKTUR. Alt tipler: düşük iştah/ilgi, duyuusal temelli kaçınma, olumsuz sonuç korkusu (boğulma/kusma). Organik nedenler dışlanmadan ARFID tanısı verilmez.

Beslenme reddi/iştahsızlık nadiren tek nedenlidir; genellikle organik bir tetikleyici (ağrı, disfaji, reflü) öğrenilmiş kaçınma ve olumsuz beslenme etkileşimiyle birleşir. Mekanizmayı yaş filtresi ile birlikte değerlendirmek en olası tanıyı daraltır. Aşağıdaki kategoriler sıklıkla eş zamanlıdır ve dört PFD alanına eşlenir.

Organik — üst GİS / mukozal

- GÖRH ve reflü özofajiti: ağrılı yutma → öğün ilişkili irritabilite, kavis-boyun gerginliği (Sandifer), beslenme reddi.
- EoE: küçük çocukta beslenme reddi, kusma, büyüme geriliği ile atipik; büyük çocukta katı disfaji/food impaction. Atopi ile güçlü birliktelik (≥ 15 eos/BBA).
- İnek sütü protein alerjisi (İMPA), enfeksiyöz/eroziv özofajit.

Oral-motor / disfaji (beceri)

- Orofaringeal disfaji; emme-yutma-solunum koordinasyon bozukluğu (prematürite, nöromusküler hastalık, serebral palsi).
- Aspirasyon/penetrasyon: öksürük, ıslak-boğuk ses, öğünde desatürasyon, tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu.
- Tekstür ilerletememe, kıvama özgü red; oral duyuşal işleme sorunu.

Anatomik / yapısal

- Yarık damak-dudak, laringeal yarık, larengomalazi, koanal atrezi, mikrognati/Pierre Robin.
- Özofagus atrezisi/TÖF onarımı sonrası anastomoz darlığı, konjenital özofagus stenozu, vasküler halka dış bası.
- Malrotasyon/kısmi obstrüksiyon, antral web (kusma-beslenme reddi ile).

Sistemik / iştah kaybı

- Kronik hastalık: konjestif kalp yetmezliği, KBH, malignite, kistik fibrozis, IBD, kronik enfeksiyon/inflamasyon (artmış enerji tüketimi + iştah baskılanması).
- Mikrobesein eksikliği (çinko, demir), kronik kabızlık, çölyak hastalığı.
- İlaç etkisi (metilfenidat, topiramat, kemoterapi), metabolik/endokrin bozukluk.

Davranışsal / duyuşal — ARFID

- Duyuşal temelli seçicilik (doku/renk/koku), yeni gıda korkusu (neofobi), aşırı sınırlı repertuar.
- Olumsuz sonuç korkusu: boğulma/kusma sonrası koşullu (öğrenilmiş) red, travmatik öğün deneyimi.
- Düşük iştah/yeme ilgisizliği tipi; sonda beslenmesine bağımlılık ve oral-aversiyon.

Psikososyal + yaşa göre dağılım

- Etkileşim: zorla/baskıcı besleme, öğün çatışması, ebeveyn kaygısı, olumsuz öğün ortamı; nadiren ihmal/yoksunluk.
- Süt çocuğu: emme-yutma disfonksiyonu, prematürite, GÖRH, İMPA, konjenital anomali.
- Toddler: fizyolojik iştah azalması ve neofobi (normal), seçici yeme, demir/çinko eksikliği. Okul çağı/adölesan: ARFID, EoE, kronik hastalık, depresyon/kaygı.

Toddler döneminde büyüme hızının yavaşlamasına bağlı fizyolojik iştah azalması ve neofobi normaldir; büyüme eğrisi korunuyor, gelişim normal ve kırmızı bayrak yoksa güvence ve ebeveyn eğitimi yeterlidir. Ayrım noktası büyümenin sürdürölüp sürdürölmediğidir.

03 Karar akışı

İlk basamak disfaji/aspirasyon ve büyüme çöküşü gibi tehdit edici durumların dışlanmasıdır; ardından organik-mukozal hastalık (GÖRH/EoE), sistemik/nutrisyonel neden ve davranışsal (ARFID) zemin sırayla değerlendirilir. Amaç, düzeltilebilir organik nedeni tedavi ederken beslenmeyi güvence altına almak ve gerekli olguyu multidisipliner beslenme ekibine yönlendirmektir.

BAŞLANGIÇ

Beslenme reddi / iştahsızlık ile başvuru

Öykü, muayene, doğrudan beslenme gözlemi; büyüme eğrisi, dört PFD alanı ve yaş filtresi ile ilk çerçeveleme.

ADIM 1

Dört alan + güvenlik taraması

Medikal-beslenme-beceri-psikososyal alanlar; antropometri/trend, hidrasyon ve kırmızı bayrak (disfaji, aspirasyon, büyüme çöküşü) değerlendirilir.

KARAR 1

Disfaji/aspirasyon veya akut tehdit var mı?

Öğünde öksürük-boğulma, ıslak-boğuk ses, desatürasyon, tekrarlayan pnömoni, ağır dehidratasyon veya hızlı büyüme çöküşü var mı?

EVET → Güvenli beslenme önceliği

HAYIR → Elektif ayırım

ALARM

Yutma değerlendirmesi + hava yolu/anatomi

VFSS/FEES ile aspirasyon-faz güvenliği; kıvam uyarlaması, gerekiyorsa geçici enteral (NG) destek; anatomik/nöromusküler neden ve dehidratasyon eş zamanlı yönetilir.

ADIM 2

Organik hastalık ipuçlarını tara

Ağrılı yutma, kusma, dispepsi, hematemez, atopi, büyüme geriliği gibi organik-mukozal ipuçlarını değerlendir.

KARAR 2

GÖRH/EoE veya mukozal hastalık ipucu mu?

Ağrılı yutma, öğün ilişkili irritabilite, kusma-regürjitasyon, food impaction, atopi veya alarm bulgusu var mı?

EVET → Mukozal tanı ve tedavi

ADIM 3A

Üst GİS endoskopisi + çok düzeyli biyopsi

EoE (≥ 15 eos/BBA), reflü/erozif özofajit ve İMPA değerlendirilir; GÖRH/EoE'ye yönelik tedavi başlanır (bkz. Basamak 06).

HAYIR → Sistemik/nutrisyonel tarama

ADIM 3B

Düzeltililebilir sistemik nedeni ara

Tam kan-ferritin-çinko-CRP, çölyak serolojisi, kabızlık, kronik hastalık ve ilaç etkisi taranır; saptanan neden düzeltilir.

KARAR 3

Büyüme yetersiz / nutrisyonel risk var mı?

Kilo kaybı, z-skor düşüşü, büyümede duraklama veya mikrobesein eksikliği mevcut mu?

EVET → Beslenme rehabilitasyonu

ADIM 4

Enerji yoğunlaştırma + replasman ± destek

Kalori-yoğun beslenme, mikrobesein (çinko/demir) replasmanı, seçilmiş olguda iştah açıcı; hedefe ulaşamıyorsa geçici enteral (NG/GT) destek.

HAYIR → Büyüme korunmuş

ADIM 5

Beceri ve davranış paternini değerlendir

Oral-motor beceri normal mi, davranışsal/ARFID paterni mi? Beslenme etkileşimi ve öğün ortamı gözden geçirilir.

KARAR 4

Organik neden dışlandı, davranışsal/ARFID mı?

Medikal ve nutrisyonel neden düzeltildikten sonra kaçınma/seçicilik/düşük ilgi paterni sürüyor mu?

EVET → Multidisipliner beslenme terapisi

SONLANIM

Davranışsal + oral-motor terapi ekibi

Beslenme terapisti/dil-konuşma, diyetisyen, psikoloji; kademeli maruz bırakma, olumlu öğün rutini. Zorla besleme yok. Gerekliyse ARFID için BDT.

HAYIR → Organik neden aktif

DEVAM

Nedene yönelik tedaviye devam

Saptanan GÖRH/EoE/disfaji/sistemik hastalığın tedavisi sürdürülür; yanıt ve büyüme ile yeniden değerlendirilir.

Anahtar ilke: Beslenme reddi çoğunlukla çok etkenlidir; organik tetikleyiciyi (ağrı, reflü, disfaji) tedavi etmek gerekli ama çoğu zaman tek başına yeterli değildir. Organik neden düzeltildikten sonra süren red,

öğrenilmiş kaçınmayı ele alan multidisipliner beslenme terapisini gerektirir. Büyüme, tüm kararlarda önceliklidir.

Tetkik klinik tabloya göre yönlendirilir: her olguda dört alan değerlendirmesi ve büyüme takibi; disfaji/aspirasyon şüphesinde yutma çalışması; GÖRH/EoE şüphesinde biyopsili endoskopi; büyüme geriliğinde hedefli laboratuvar. Aşırı tetkikten kaçınılır — davranışsal seçici yeme ve fizyolojik toddler iştahsızlığında geniş panel gereksizdir.

Beslenme reddi/iştahsızlıkta basamaklı tanısal yaklaşım ve endikasyonlar

BASAMAK / TEST	NE ZAMAN
Klinik + dört alan değerlendirme	Tüm olgular
Antropometri + diyet günlüğü	Büyüme eğrisi + 3 günlük alım
Videofloroskopik yutma çalışması (VFSS) / FEES	Disfaji / aspirasyon şüphesi
Üst GiS endoskopisi + çok düzeyli biyopsi	Proksimal + distal ≥ 6 parça
Hedefli laboratuvar	Tam kan, ferritin, çinko, CRP, elektrolit, tTG-IgA

BASAMAK / TEST	NE ZAMAN
İMPA / besin alerjisi deęerlendirmesi	Süt çocuęu, atopi, GİS bulguları
Baryumlu özofagogram / üst GİS pasaj	Anatomik / motilite şüphesi
pH-empedans (MII-pH)	Seçilmiş — GÖRH şüphesi
ARFID / psikososyal deęerlendirme	Organik dışlandıęında

Yaygın hata iki uçtadır: (1) alarm bulgusu olan çocukta organik nedeni araştırmamak, (2) büyümesi korunmuş, kırmızı bayrağı olmayan seçici yiyicide gereksiz geniş tetkik ve endoskopi yapmak. Tetkik yoğunluęu büyüme riski ve alarm bulgularıyla orantılı olmalıdır.

Aşağıdaki bulgular organik/tehdit edici bir zemini işaret eder; davranışsal/fonksiyonel varsayımı geçersiz kılar ve hızlandırılmış tanısal-girişimsel değerlendirme gerektirir.

- Öğünde öksürük-boğulma, ıslak-boğuk ses, desatürasyon veya belgelenmiş aspirasyon.

- Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu / aspirasyon pnömonisi.

- İlerleyici kilo kaybı, büyümede duraklama veya z-skorda belirgin düşüş.

- Disfaji + food impaction öyküsü, odinofaji (EoE/striktür).

- Kusma (özellikle safralı), hematemez, melena veya GIS kanaması.

- Kronik ishal/kanlı gaita, karın distansiyonu (İMPA, çölyak, IBD, obstrüksiyon).

- Dehidratasyon, letarji veya enteral desteğe bağımlılık.

- Yenidoğan/erken süt çocuğunda beslenmeyle mor olma, stridor (vasküler halka, laringeal yarık, atrezi).

- Nörolojik gerileme, gelişimsel regresyon veya yeni bulgu.

- Ateş, gece terlemesi, organomegali veya sistemik hastalık işaretleri.

Aspirasyon riski ve ağır dehidratasyon/büyüme çöküşü acil durumlardır: güvenli beslenme yolu (kıvam uyarlaması, gerekirse geçici enteral destek) sağlanmadan oral zorlama sürdürülmez; anatomik/nöromusküler neden ve sıvı-elektrolit dengesi eş zamanlı ele alınır.

06 Tedavi — dozlu

Tedavi çok bileşenlidir: (1) altta yatan organik nedeni (GÖRH, EoE, İMPA, kabızlık, mikrobesein eksikliği) hedefe yönelik tedavi et; (2) beslenmeyi enerji-yoğunlaştırma ve gerektiğinde enteral destekle güvence altına al; (3) öğrenilmiş red ve seçiciliği multidisipliner beslenme/oral-motor terapisiyle ele al. İştah açıcı ilaçlar yalnızca düzeltilebilir neden dışlandıktan sonra ve büyüme riski varken, ek olarak kullanılır. Dozlar hastaya göre bireyselleştirilmelidir.

Organik: GÖRH/EoE/İMPA/kabızlık tedavisi

Nutrisyon: kalori-yoğunlaştırma ± enteral

Mikrobesein: çinko / demir replasmanı

Davranış: multidisipliner terapi

Nedene yönelik ve destekleyici tedavi — doz (mg/kg) ve maksimumlar

AJAN / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Omeprazol (belgelenmiş GÖRH/özofajit)	1-2 mg/kg/gün (maks 40 mg/gün)
Omeprazol (EoE, yüksek doz PPI)	1-2 mg/kg/gün, 2 doza bölünmüş (maks 40 mg/gün)
Oral viskoz budesonid (EoE, yutulan)	<10 yaş 1 mg/gün; ≥10 yaş 2 mg/gün (maks 2 mg/gün)

AJAN / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Ekstansif hidrolize / aminoasit formül (İMPA)	Eliminasyon 2-4 hafta, sonra provokasyon
Kalori yoğunlaştırma	Formül 0.8-1.0 kcal/mL; hedef ~%25-50 artış
Çinko (eksiklik replasmanı)	Elementer 1 mg/kg/gün (maks 20-40 mg/gün), 2-3 ay
Elementer demir (eksiklik anemisi)	3-6 mg/kg/gün (maks 150-200 mg/gün)
Polietilen glikol 3350 (eşlik eden kabızlık)	İdame 0.4-0.8 g/kg/gün; disimpaksiyon 1-1.5 g/kg/gün

AJAN / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Siproheptadin (iştah açıcı)	0.25 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş; 2-6 yaş maks 1
Enteral tüp beslenme (NG / gastrostomi)	Geçici NG; kalıcı/uzun süreli GT
Multidisipliner beslenme terapisi	Girişim — yapılandırılmış program
ARFID — bilişsel davranışçı tedavi (BDT-AR)	Girişim — yaşa uyarlanmış

Zorla besleme ve öğün baskısı beslenme reddini pekiştirir ve oral-aversiyonu derinleştirir; tedavinin temeli baskısız, olumlu ve öngörülebilir öğün rutinidir. İştah açıcı ve enteral destek yardımcıdır, davranışsal terapinin ve organik tedavinin yerine geçmez.

Amaç: büyüme ve nutrisyonel durumu güvence altına almak, organik nedeni objektif olarak tedavi etmek (EoE'de histoloji, GÖRH'de semptom yanıtı) ve öğrenilmiş redi kalıcı olarak çözmektir. İzlem tek uzman değil, koordine bir ekip işidir; ebeveyn eğitimi ve öğün ortamı düzenlemesi her aşamada sürekli dir.

Nutrisyonel ve medikal izlem

- Büyüme eğrisi ve z-skoru düzenli izle; hedef yakalama büyümesi (catch-up) ve nutrisyonel parametrelerin normalizasyonu.
- EoE'de indüksiyon sonrası 8-12 haftada kontrol endoskopi + biyopsi ile histolojik remisyon (<15 eos/BBA); yanıtta idame sürdür.
- GÖRH tedavisinde yanıt değerlendir ve gereksiz uzun PPI kullanımından kaçın; İMPA'da kademeli reintrodüksiyon planla.
- Mikrobese replasmanını laboratuvarla (ferritin, çinko) izle; enteral destekte oral becerileri koruyacak oral uyararı sürdür ve azaltma (weaning) planı yap.

Beceri, davranış ve psikososyal izlem

- Oral-motor beceriyi dil-konuşma/beslenme terapisti ile izle; tekstür ilerlemesi ve güvenli yutma hedeflenir.
- Davranışsal programda kademeli gıda genişletme, repertuar artışı ve öğün süresi/ çatışmasında azalma takip edilir.
- Ebeveyn koçluğu: baskısız besleme, yapılandırılmış öğün-atıştırma düzeni, olumlu pekiştirme; kaygı ve öğün stresini azalt.
- ARFID/anksiyete eşliğinde psikoloji-psikiyatri iş birliği; ağır/dirençli olguda beslenme programına yönlendir.

Geri çekilme ve devam kuralı: Organik hastalık (EoE, GÖRH, İMPA) objektif remisyon doğrulanmadan tedavi kesilmez; enteral destek ve iştah açıcı, büyüme ve oral alım güvenli biçimde sürdürülebilir hale gelince kademeli azaltılır. Davranışsal ilerleme yavaştır — süreklilik, tutarlılık ve multidisipliner koordinasyon başarının anahtarıdır.

1. Goday PS, Huh SY, Silverman A, ve ark. Pediatric Feeding Disorder: Consensus Definition and Conceptual Framework. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019;68(1):124-129.
2. Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, ve ark. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(3):516-554.
3. Amil-Dias J, Oliva S, Papadopoulou A, ve ark. Diagnosis and management of eosinophilic esophagitis in children: An update from the ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024;79(2):394-437.
4. American Psychiatric Association. Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder. DSM-5-TR. 2022; ve Zeevenhooven J, ve ark. Rome IV bebek/toddler fonksiyonel GİS bozuklukları. Gastroenterology. 2016;150(6):1443-1455.

Uyarı: Bu belge çocuk gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteği amaçlıdır; hastaya özgü değerlendirmenin, güncel kılavuzların ve yerel ilaç ruhsat/dozaj bilgilerinin yerine geçmez. Dozlar hastanın yaşı, kilosu, böbrek/karaciğer fonksiyonu ve komorbiditelerine göre bireyselleştirilmelidir.